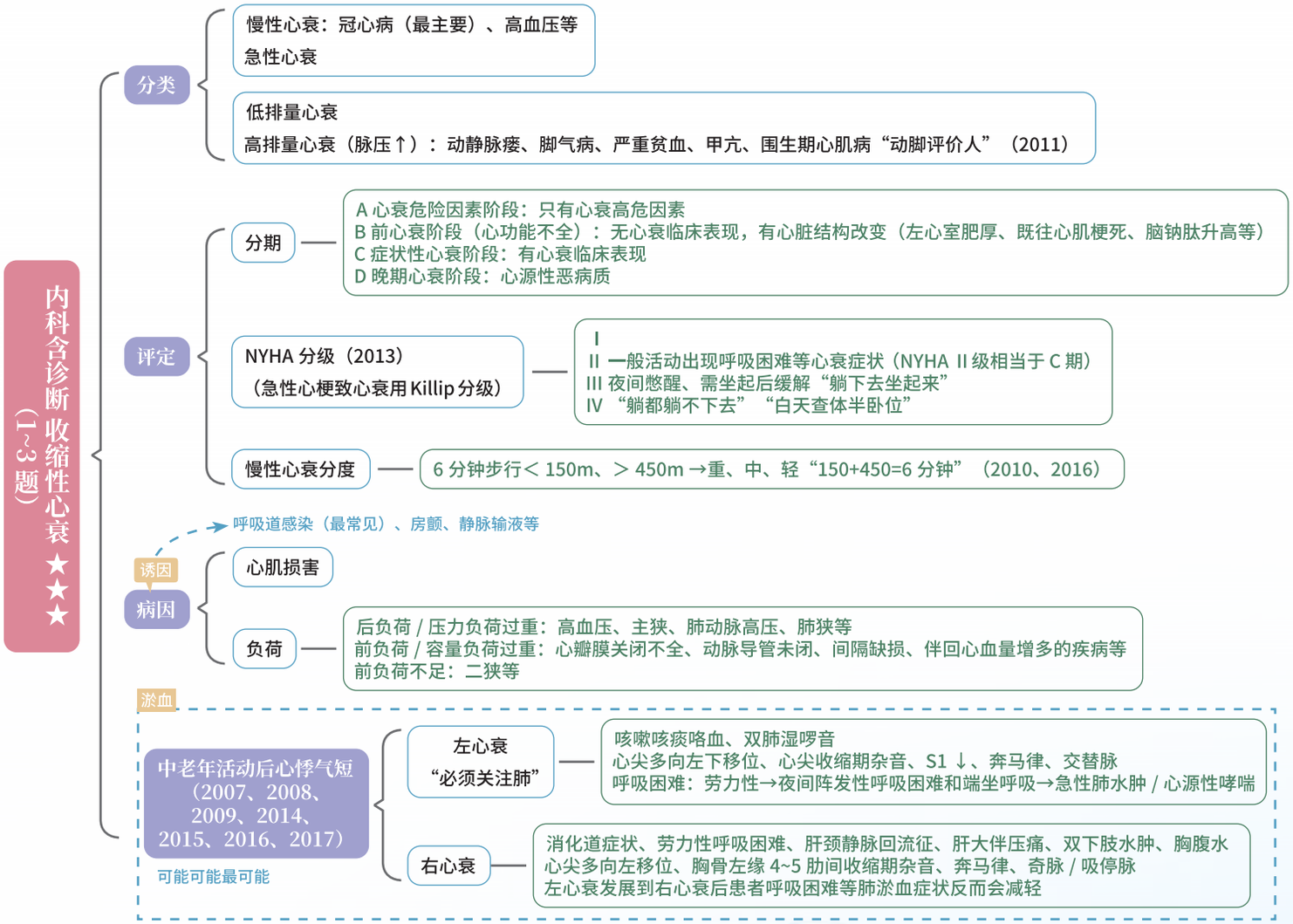

内科含诊断收缩性心衰★★★（1~3题）
分类
慢性心衰：冠心病（最主要）、高血压等
急性心衰
低排量心衰
高排量心衰（脉压↑）：动静脉瘘、脚气病、严重贫血、甲亢、围生期心肌病“动脚评价人”（2011）
评定
分期
A 心衰危险因素阶段：只有心衰高危因素
B 前心衰阶段（心功能不全）：无心衰临床表现，有心脏结构改变（左心室肥厚、既往心肌梗死、脑钠肽升高等）
C 症状性心衰阶段：有心衰临床表现
D 晚期心衰阶段：心源性恶病质
NYHA 分级（2013）
（急性心梗致心衰用 Killip 分级）
I
II 一般活动出现呼吸困难等心衰症状（NYHA II 级相当于 C 期）
III 夜间憋醒、需坐起后缓解“躺下去坐起来”
IV “躺都躺不下去”“白天查体半卧位”
慢性心衰分度
6 分钟步行＜ 150m、＞ 450m →重、中、轻“150+450=6 分钟”（2010、2016）
病因
诱因
呼吸道感染（最常见）、房颤、静脉输液等
心肌损害
负荷
后负荷 / 压力负荷过重：高血压、主狭、肺动脉高压、肺狭等
前负荷 / 容量负荷过重：心瓣膜关闭不全、动脉导管未闭、间隔缺损、伴回心血量增多的疾病等
前负荷不足：二狭等
淤血
中老年活动后心悸气短（2007、2008、2009、2014、2015、2016、2017）
可能可能最可能
左心衰
“必须关注肺”
咳嗽咳痰咯血、双肺湿啰音
心尖多向左下移位、心尖收缩期杂音、S1 ↓、奔马律、交替脉
呼吸困难：劳力性→夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸→急性肺水肿 / 心源性哮喘
右心衰
消化道症状、劳力性呼吸困难、肝颈静脉回流征、肝大伴压痛、双下肢水肿、胸腹水
心尖多向左移位、胸骨左缘 4~5 肋间收缩期杂音、奔马律、奇脉 / 吸停脉
左心衰发展到右心衰后患者呼吸困难等肺淤血症状反而会减轻